

抗がん剤の分類と作用機序:薬剤師の実践ポイント

服薬指導・相互作用・病院との連携のポイント

1 実践チェックリスト(保険薬局/病院)

保険薬局薬剤師	病院と共有する情報	病院薬剤師
1 経口抗がん剤の服用時点・服用日・残薬の管理	レジメン名・投与日 (お薬手帳)	1 レジメン監査・投与量計算・前投薬の確認
2 他院処方・市販薬・サブリを含む相互作用の確認	検査値 (処方箋への印字など)	2 抗がん剤の調製と曝露対策
3 服用期間中の電話フォローと早期受診の勧奨	副作用のGrade (トレーシングレポート)	3 外来化学療法室での副作用説明・導入時の指導
4 副作用をGradeで記録し、トレーシングレポートで病院へ	服用状況・残薬 (電話フォローの結果)	4 副作用発現時の院内連携(各診療科)
5 家庭での曝露対策・長期服用のアドヒアランス支援		5 お薬手帳へのレジメン情報の記載・薬局への情報提供

2 経口抗がん剤の服用時点と注意点

S-1	食後 1日2回 朝夕食後	✓ 4週服用・2週休薬などの休薬期間 ✓ 腎機能に応じた用量 ✓ 他のフッ化ピリミジン系と併用禁忌
カペシタビン	食後 1日2回 朝夕食後30分以内	✓ 手足症候群 ✓ ワルファリン併用時のINR上昇
エルロチニブ	空腹時 1日1回 空腹時(食事の1時間以上前または食後2時間以降)	✓ 皮疹・下痢 ✓ 胃酸分泌抑制薬で吸収低下 ✓ 喫煙で濃度低下
ニロチニブ	空腹時 1日2回 空腹時(同上)、約12時間ごと	✓ QT延長 ✓ グレープフルーツ ✓ 胃酸分泌抑制薬
アビラテロン	空腹時 1日1回 空腹時(食事の1時間前～食後2時間は避ける)	✓ プレドニゾロンの併用 ✓ 肝機能・低K血症・高血圧
レゴラフェニブ	食後 1日1回 食後(高脂肪食の後は避ける)	✓ 手足症候群 ✓ 投与初期の肝機能・血圧
タモキシフェン	食事に関係なく 1日1回(食事に関係なく)	✓ CYP2D6阻害薬(パロキセチン等) ✓ 血栓症・子宮体がん

● 空腹時 ● 食後 ● 食事に関係なく ● 指示どおり 服用時点は交付時に具体的な時刻で説明

3 相互作用・併用注意(他院処方・市販薬・サブリを含む)

重要度	薬剤(機序)	相手の薬(区分)	起こること	薬局での対応
禁忌 添付文書 併用禁忌	S-1 DPD阻害(ギメラシル)	処方薬 他のフッ化ピリミジン系(カペシタビン・5-FU等)	5-FU濃度↑ → 重篤な骨髄抑制・下痢	切り替え時は7日以上空ける
注意 添付文書 警告	カペシタビン CYP2C9の抑制	処方薬 ワルファリン	INR↑ → 出血	INR測定を頻度を処方医と確認
注意 添付文書 併用注意	経口分子標的薬(イマチニブ等) CYP3A4阻害・誘導	処方薬 クラリスロマイシン・アゾール系・リファンピシン	副作用↑・効果↓	他院の抗菌薬・抗真菌薬・抗結核薬を確認
注意 添付文書 併用注意	エルロチニブ・ダサチニブ等 胃内pH上昇で吸収低下	処方薬 市販薬 PPI・H2ブロッカー(市販の胃薬も)	血中濃度↓ → 効果減弱	市販の胃薬も確認、服用時間を調整
注意 添付文書 併用注意	経口分子標的薬 CYP3A4阻害・誘導	サブリ・食品 グレープフルーツ・セイヨウオトギリソウ	副作用↑・効果↓	食品・サブリの摂取を聴取
注意 添付文書 併用注意	タモキシフェン CYP2D6阻害(活性化↓)	処方薬 パロキセチン等のSSRI	効果減弱のおそれ	他院の抗うつ薬の処方を確認

4 服薬指導の声かけ例と確認のタイミング

① 治療開始前	② 開始～2週	③ 1～3か月	④ 長期服用中
“がん細胞の増殖のスイッチを止める薬です。毎日決まった時間に飲み続けることが大切です”	“熱や下痢、皮膚の変化など、今までと違う症状があれば、次の受診を待たずに教えてください”	“だるさや口の渇き、動悸が続く時も連絡を。免疫の薬は時間がたってから症状が出るがあります”	“関節の痛みやほてりは対処法があります。自己判断でやめずに相談してください”
✓ 薬局で確認 お薬手帳でレジメン・分類、他院処方・市販薬・サブリ	✓ 薬局で確認 電話フォローで分類ごとの初期症状(発熱・皮疹・下痢)を確認	✓ 薬局で確認 ICIのirAE、家庭血圧・尿蛋白(血管新生阻害薬)	✓ 薬局で確認 ホルモン剤・分子標的薬の継続状況と残薬、骨密度検査
△ ここに注意 経口薬は粉碎・脱カプセルしない(曝露対策)	△ ここに注意 発熱・水様便が続く時は至急連絡	△ ここに注意 息切れ・空咳・発熱はILDを疑い早めに受診	△ ここに注意 自己中断・飲み忘れはトレーシングレポートで共有